Questões de Reumatologia

46 questões preservadas. Respostas preexistentes removidas; a numeração e eventuais erros de redação do material de origem foram mantidos.

QUESTÃO 01

Mulher de 45 anos, branca, professora, procura o ambulatório com queixas de dor e edema em mãos e punhos, associada a rigidez matinal de noventa minutos, há pelo menos 5 minutos. Nega outras queixas. Ao exame físico, observa-se artrite de punhos; 2ª e 3ª metacarpofalangeanas, bilateralmente; 2ª/3ª/4ª interfalangeanas proximais, bilateralmente; atrofia de interósseos; 2º/3º dedos em pescoço de cisne, bilateralmente. Traz os seguintes exames: Hemograma normal; fator reumatoide positivo; FAN negativo; VHS e PCR elevadas. Quais as alterações radiográficas esperadas nesse caso?

QUESTÃO 02

JR, 49 anos, branca, professora, procura o ambulatório com queixa de dor disseminada em todo o corpo, ansiedade, nervosismo, insônia e irritabilidade. Interrogatório sintomatológico: refere obstipação intestinal crônica. Ao exame físico, apresenta 14 tender points e não apresenta artrite ou deformidades articulares. Traz os seguintes exames: hemograma normal, fator reumatoide negativo, FAN negativo, TSH normal, VHS e PCR normais. Sobre esse caso, pode-se afirmar que:

QUESTÃO 03

Homem de 28 anos relata dor lombar, que se iniciou há fez anos, que piora com o repouso e melhora com o movimento, associada a rigidez matinal de uma hora. Informa também dor nos ombros e na coluna cervical. Não está conseguindo dormir a noite. Ao exame físico, observa-se retificação lombar e teste de Patrick Fabere positivo, bilateralmente. Qual o provável diagnóstico e exame a ser solicitado, nesse caso?

QUESTÃO 04

Homem de 59 anos, refere dor em joelhos, cotovelos e dorso dos pés, de inicio há mais de 10 anos. Relata que no inicio a dor era episódica e acometia principalmente os pés(pododáctilos e tornozelos), mas nos últimos dois anos está quase constante, com crise a cada dois meses, associada ao aparecimento de nodulações, nos cotovelos e nos pés. Atualmente, está sem crise. Faz uso constante de anti-inflamatório não hormonal. Traz os seguintes exames complementares: IIb = 14,0 g/dL; leucócitos = 5.000/mm³ (diferencial normal); plaquestas = 180.000/mm³. VHS = 50mm. URreia/creatinina/TGO/TGP/Glicemia -= normais. RX pés = lesão em saca bocado nas primeiras MTFs, bilateralmente, e nos ossos do tarso. Qual a principal hipótese diagnóstica e conduta para esse caso?

QUESTÃO 05

Mulher de 58 anos, profissão de salgadeira, relata parestesia no primeiro, segundo e terceiro dedos da mão direita. Após a valiação, o acadêmico de medicina concluiu que a paciente tinha síndrome do túnel do carpo. Que manobra de exame físico auciliou o acadêmico a chegar a essa conclusão?

QUESTÃO 06

O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória, autoimune, com formação de imunocomplexos, que teve seus critérios de classificação reavaliados em 2012. De acordo com essa reavaliação, fazem parte dos novos critérios da doença:

QUESTÃO 07

A oesteoporose é uma enfermidade caracterizada por redução na densidade mineral óssea e aumento no risco de fraturas. Sobre essa doença, é correto afirmar

a) A atv física de impacto deve ser evitada, pelo risco de fratura
b) A teriparatida é a droga de escolha no tto da osteoporose com fratura
c) A densitometria óssea deve ser realizada em todas as mulheres, a partir dos 40 anos
d) Quando indicado o uso do alendronato, não é necessário prescrever cálcio e vitamina D

QUESTÃO 08

Os autoanticorpos são imunoglobulinas que reagem contra os constituintes do próprio organismo e podem ser encontrados em varias doenças, além das doenças auto-imunes. No caso do Fator Reumatóide, esse autoanticorpo pode ser encontrado em quais das situações?

a) Síndrome de Sjogren
b) Hepatite C
c) Idosos

QUESTÃO 09

A osteoartrite é uma doença caracterizada por dor articular e limitação dos movimentos. Radiologicamente, caracteriza-se por:

QUESTÃO 10

A lesão da membrana celular gera o ácido araquidônico, o qual sob a ação enzimática das ciclooxigenases se transforma em várias substancias. Sobre as ciclooxigenases, póde-se afirmar que:

QUESTÃO 11

Paciente masc, 23 anos, natural e procedente de Goiania – GO, administrador de empresa, procurou o ambulatório com quadro de dor e aumento de volume de tornozelos e joelho D, de início há 1 mês. Referia antecedente de uretrite, tratado por urologista, há 2 meses. Ao exame físico, apresentava artrite de tornozelos (D e E) e joelh D; e hiperemia conjuntival à D. Ausencia de lesões cutâneas palmo-plantares. A principal hipótese diagnóstica nesse caso é:

QUESTÃO 12

Paciente fem, 68 anos, natural e procedente de abadiania, passadeira de roupas, procura o ambulatório com queixa de dor em mãos e ombros, de inicio há 3 anos, que melhora com o repouso e piora com o esforço físico. Nega sintomas concomitantes. Ao exame físico, apresenta dor e limitação aos movimentos do ombro D, nodulações dolorosas à palpação em IFPs e IFDs, e dor aos movimentos do punho D. Quais exames complementares são essenciais na investigação diagnóstica?

QUESTÃO 13

Paciente masc, 43 anos, natural e procedente de GOiania, bancário, procurou assistência médica com dor e edema no joelho D há 2 dias. Referia quadro semelhante no tornozelo esquerdo há 6 meses. Antecedente de hiperten~são arterial sistêmica em uso de HCTZ. Relatava etilismo e tabagismo. Ao exame físico, apresentava eritema, aumento de volume, calor e dor em joelho D. Qual deve ser o melhor esquema terapêutico após feita a principal hipótese diagnóstica?

QUESTÃO 14

Paciente fem, 18 anos, natural e procedente de Trindade, procurou o CAIS referindo dor nas interfalangeanas proximais e punhoas há 6 meses, com piora há 2 meses, quando iniciou edema das articulações referidas, rigidez matinal de 1 hora, febre, tosse seca e dor torácica ventilaróio dependente. Relatava antecedente de púrpura trombocitopênica há 1 ano quando teve que usar corticoide. Trazia um hemograma com anemia normocítica e normocromica sem outras alterações. Quais exames complementares são necessários na investigação da principal hipótese diagnóstica?

QUESTÃO 15

Paciente fem, 48 anos, procura o ambulatório, com queixas de dor e edeme em punhos, 2º/3º interfalangeanas proximais bilateralmente há 4 meses, associado a rigidez matinal de duas horas. Interrogatório sintomatológico: negava erupção cutânea, fotossensibilidade, ulceras orais, fenômeno de Raynaud, assim como queixas cardiorrespiratórias e genitourinparias. Antecedentes: previamente hígida. Mae com tireoidite autoimune. Exame físico: artrite em punhos, 2º/3º metacarpofalangeanas bilateralmente e 2º/3º interfalangeanas proximais bilateralmente, sem outras anormalidades. Exames realizados: Hemograma normal, VHS = 68 mm, PCR = positiva. Fator Reumatóide = negativo, FAN = negativo, Rx e USG das mãos normais. Os exames complementares mais importantes para a elucidação diagnóstica são:

QUESTÃO 16

Em uma paciente de 43 anos, com poliartrite crônica, de acometimento de mãos e pés, procedente da região central do Brasil, além da investigação para artrite reumatoide, é fundamental o diagnóstico diferencial com:

QUESTÃO 17

Na suspeita de artrite microcristalina por cristais de monourato de sódio, a análise do líquido sinovial por microscopia de luz polarizada deverá demonstrar cristais com:

QUESTÃO 18

São considerados fatores de risco para osteoporose:

QUESTÃO 19

No diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, a hiperflexão forãda dos punhos pode desencadear os sintomas de dor e parestesia no território do nervo mediano. Tal manobra é conhecida como teste de:

QUESTÃO 20

A manobra de Patrick-Fabere, quando positiva, indica:

QUESTÃO 21

Paciente masc, de 25 anos, previamente hígido, procura serviço médico com queixa de dor e edema volumoso em joelho direito há dois dias. Refere ter jogado futebol com amigos, precedendo o quadro. Relata promiscuidade sexual. A conduta adequada a ser adotada é:

QUESTÃO 22

Em relação às espondiloartropatias, é INCORRETO afirmar que:

QUESTÃO 23

Em relação à epidemiologia das doenças reumáticas, é CORRETO afirmar que:

QUESTÃO 24

Em relação à fibromialgia, é correto afirmar que:

QUESTÃO 25

Em relação à síndrome do túnel do carpo, é correto afirmar que:

QUESTÃO 26

Segundo o Consenso Brasileiro de Artrite Reumatoide, são fatores que indicam pior prognóstico em pacientes com artrite reumatoide:

QUESTÃO 27

Segundo o Consenso Brasileiro de Artrite Reumatoide, são fatores que indicam pior prognóstico em pacientes com artrite reumatoide:

QUESTÃO 28

Em um paciente com FAN positivo, a possibilidade de ele apresentar lúpus eritematoso sistêmico é mais relevante, na presença de auto-anticorpo:

QUESTÃO 29

Paciente masc 22 anos, branco, lavrador, natural de sorriso MT, procedente de rio verde, procura o HC com queixa de dor lombar à direita, de início há 2 anosm que piora com o repouso e no período noturno, e melhora durante o dia. Relata rigidez matinal de até meia hora. No IS, refere dor em calcanhares, intermitente e alternante, há 6 meses. Há uma semana, apresentando dor no olho esquerdo, fotofobia e diminuição da acuidade visual. Nesse caso, a principal hipótese diangóstica é:

QUESTÃO 30

Paciente, fem, 52 anos, negra, serviços gerais, natural de ouro preto MG, procedente de mineiros, refere dor em mãos, ombros, joelhos e coluna lombar, de inicio há 3 anos e piora progressiva. Relata inchaço dos joelhos, principalmente quando permanece longos períodos de pé. Ao exame físico: ausência de artrite; presença de nodulações, de consistência endurecida, em IFPs e IFDs; crepitação em joelhos, principalmente à direita; limitação aos movimentos do segmento lombar. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é:

QUESTÃO 31

Paciente, masc, 45 anos, refere dor e edema na 1ª metatarsofalangeana a direita iniciado na madrugada (há 8 h). Relata episódios anteriores semelhantes em 1ª metatarso falangeanas, tornozelos e dorso dos pés. Traz uma dosagem de ácido úrico sérico de 11 mg/dl realizada há um mês. É hipertenso, em uso de HCTZ 25 mg/d, anlodipina 5mg/d e AAS 100mg/d. Nesse caso, a conduta terapêutica inicial é:

QUESTÃO 32

Paciente, fem, 23 anos, deu entrada no P.S. do HC, referindo falta de ar há 1 mês, com pior há 3 dias. Relatava dor e edema nas articulações das mãos (IFPs e punhos) e joelhos há 6 meses. Referia também edeme de MMII e urina espumosa. Ao exame físico: BEG, hipocorada +/4+, dispneica, afebril, PA 140/90 mmHg. ACV: RCR, 2T, BNF, sem sopro, FC 100 bpm. AR: MV diminuído em base de hemitórax D. Abdome: flácido, indolor a palpação sem visceromegalias. Articular: Edema e dor a palpação e movimentaão das 2ªs e 3ªs e 4ªs IFPs e joelhos. Edema de MMII 2+/4+. Ex. labs: Hemograma: Hb = 8,0, Leucocitos : 2000; Plaquestas: 50.000; VHS : 80 m/h (VR<20); ASO : 540 * (VR<200); Fator reumatoide : 10 UI/ml (VR <20); FAN : 1/640 nuclear pontilhado grosso. Eletroforese de proteínas: hipoalbuminemia e gamopatia policlonal. A radiografia de tórax com derrame pleural à D. Nesse caso, a melhor hipótese diagnóstica é:

a) LES
b) AR
c) Sind. Sjogren
d) Artrite psoriasica

QUESTÃO 33

Paciente fem, 49 anos, branca, professora, natural e procedente de Goiânia, procurou o OS/HC com queixas de dor nas juntas. Referiu inicio dos sinomas há 4 meses, com dor e edema em punhos, 2º/3º metacarpofalangeanas (bilateralmente) e joelhos. O quadro é mais acentuado pela manha, com alivio após atividade física, associado à rigidez matinal de 2 horas. Negava outras queixas e comorbidades. Exame físico: artrite em joelhos, punhos e 2º/3º metacarpofalangeanas(bilateralmente). Nodulo subcutâneo em face extensora de cotovelo direito. Labs: Hemograma normal, VHS 56 mm (1º hora), fator reumatoide 173 UI/ml (normal < 20). Rx de mãos: erosão no processo estiloide da ulna bilateralmente. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é:

QUESTÃO 34

Em paciente do sexo feminino, adulta, com história de poliartrite cornica de mãos, ombros, joelhos e pés. Dentre os exames abaixo listados, a investigação diagnóstica deve incluir:

a) FAN
b) Pesquisa de BAAR
c) Anti – HCV

QUESTÃO 35

O fator reumatoide é um autoanticorpo descrito como uma imunoglobulina que reage contra a porção Fc da IgG. Dentre as condições clinicas abaixo, o FR pode ser encontrado em:

a) Sindrome de Sjogren
b) Osteonecrose
c) Hanseníase
d) Idosos

QUESTÃO 36

A fibromialgia é uma síndrome dolorosa difusa não inflamatória, não auto-imune e crônica, de etiologia desconhecida. É caracterizada pela presença de tender points característicos ao exame físico. Pode estar associada a inúmeras condições clínicas. Dentre elas podemos citar:

QUESTÃO 37

A osteoporose é uma desordem esquelética cuja principal característica é o comprometimento da resistência óssea, predispondo ao aumento do risco de fratura. Acerca de seu tratamento, é verdadeiro:

QUESTÃO 38

No exame físico articular a presença de crepitação pode ser observada na movimentação de várias articulações. Qual o significado desde achado do exame físico?

QUESTÃO 39

Paciente, 64 anos fem, doméstica, procurou o ambulatório com queixas de dor em joelhos, iniciada há 6 meses. Refere piora do quadro com atividade física e alívio com repouso. Nega rigidez matinal, edema articular e calor local. Exame físico: crepitações grosseiras em joelhos, sem sinais de artrite ou ruptura ligamentar. Peso: 87 kg, altura: 1,54m; Trazia consigo radiogradia de njoelhos revelando esclerose subcondral, redução do espaço articular e osteofitose. Assinale a principal hipóstese diagnóstica para o caso:

QUESTÃO 40

Paciente 49 anos, fem, branca, professora, procurou o ambulatório de reumatologia com queixas de dor e edema em punhos, 2º/3º metacarpo-falangeanas, bilateralmente e joelhos. Referia piora das queixas com o repouso e alívio com arividade física, associada a rigidez matinal de 3 horas. Sem outras queixas. Exame físico revelou artrite em punhos, 2º/3º MCF bilateralmente e joelhos. Observou-se nódulo subcutâneo na face extensora de ambos os cotovelos. Assinale abaixo os exames mais relevantes para confirmação da principal hipótese diagnóstica:

QUESTÃO 41

Paciente, 25 anos, fem, negra, auxiliar de escritório, relata dor e edema em IFPS das mãos, punhos e tornozelos há 2 meses, seguida de queda de cabelo, úlceras orais e fotossensibilidade. Traz um FAN 1/640 pontilhado grosso e VHS = 45 mm. Baseado na principal hipótese diagnóstica qual a medicação deve ser iniciada para a paciente?

QUESTÃO 42

Paciente, masc, 45 anos, foi despertado durante a madrugada por dor súbita no joelho direito associado a edema, calor e rubor. Negava febre. Relatava episódios prévios semelhantes, porem em primeira metatarsofalangeana. Etilista diário. Sedentário. A principal hipótese diagnóstica e a conduta imediata seriam:

QUESTÃO 43

Paciente, 24 anos, fem, jogadora de basquete, iniciou há cerca de 3 meses com queixa de dor em ombro direito, continua, pior a movimentação, aliviada parcialmente com uso de anti-inflamatórios. Procurou o reumatologista sendo evidenciado piora da dor com a elevação contra a resistência do braço direito (sinal de Neer positivo). O tendão possivelmente acometido é:

QUESTÃO 44

Paciente, 82 anos, sexo feminino, do lar, natural e procedente de goiania, procura assistência medica para avaliação de densitometria óssea. Tabagista há 60 anos. Nega etilismo. Nega doenças pessoais. G IX; P VIII; A I. Após avaliação da densitometria, o médico assistente conclui por osteoporose. Neste caso, a prescrição médica deverá incluir:

QUESTÃO 45

Em relação à fibromialgia, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 46

A espondilite anquilosante, é uma doença inflamatória que acomete o esqueleto axial. Quais as alterações encontradas da radiografia da coluna lombar na espondilite anquilosante?

Gabarito resumido

Elaborado independentemente das respostas que constavam no arquivo original. “Sem única” = questão não permite assinalar uma única alternativa com segurança.

Questões 1 a 16

01. Erosões marginais e osteopenia justa-articular
02. Quadro compatível com fibromialgia; amitriptilina é opção, não obrigação
03. Espondiloartrite axial (possível espondilite anquilosante); imagem das sacroilíacas
04. Gota crônica tofácea; terapia redutora de urato, geralmente alopurinol
05. Manobra de Phalen
06. Critérios SLICC 2012: mielite, alopecia não cicatricial e redução de complemento
07. SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA
08. A, B e C — todas as alternativas são verdadeiras
09. Estreitamento do espaço articular e osteófitos marginais
10. Celecoxibe: anti-inflamatório com seletividade pela COX-2
11. Artrite reativa
12. Radiografia das mãos e ultrassonografia do ombro direito
13. Suspeita de gota aguda: anti-inflamatório apropriado e exclusão de infecção
14. Investigação de LES: FAN, anti-dsDNA/anti-Sm, complemento e avaliação de órgãos
15. Anti-CCP; ressonância de mãos apenas se dúvida persistente
16. Hanseníase, entre os diagnósticos diferenciais

Questões 17 a 32

17. Cristais de urato: birrefringência NEGATIVA, em agulha
18. Baixo IMC e tabagismo
19. Teste de Phalen
20. Dor posterior no FABER pode sugerir disfunção sacroilíaca, mas não diagnostica isoladamente
21. Artrocentese urgente com estudo do líquido sinovial
22. A afirmação apresentada é INCORRETA; oligoartrite assimétrica não é a forma menos comum
23. A esclerose sistêmica predomina em mulheres, com início habitualmente na vida adulta
24. Sensação subjetiva de edema pode ocorrer na fibromialgia
25. Parestesias noturnas aliviadas ao sacudir as mãos são típicas
26. Erosões precoces, muitas articulações inflamadas e FR em alto título
27. Mesma resposta da questão 26 (questão duplicada no material)
28. Anti-Sm
29. Espondiloartrite axial / espondilite anquilosante, com possível uveíte anterior
30. Osteoartrite
31. Tratar crise de gota com AINE OU colchicina, conforme riscos clínicos
32. A — lúpus eritematoso sistêmico

Questões 33 a 46

33. Artrite reumatoide
34. Sem alternativa única garantida: A é razoável; C depende do contexto; B não é rotina
35. A, C e D — alternativas possíveis; B não é associação típica

36. Síndrome do intestino irritável
37. Desencorajar consumo excessivo de álcool
38. Crepitação pode acompanhar degeneração articular, mas é inespecífica
39. Osteoartrite de joelhos
40. FR, anti-CCP e radiografias de mãos/pés; diagnóstico essencialmente clínico
41. Hidroxicloroquina, se LES confirmado e sem contraindicação
42. Suspeita de gota aguda; AINE, colchicina ou glicocorticoide
43. Supraespinhal é hipótese plausível, não diagnóstico exclusivo
44. Em geral, bisfosfonato mais aporte adequado de cálcio e vitamina D, conforme risco
45. Fibromialgia: predomínio feminino, dor generalizada e alterações do sono
46. Sindesmófitos marginais e quadratura vertebral

Gabarito comentado

Cada resposta é acompanhada de fundamentação. Nas questões objetivas, todas as alternativas existentes são analisadas individualmente.

QUESTÃO 01

Resposta: Erosões marginais e osteopenia justa-articular

O padrão de poliartrite simétrica, rigidez prolongada, nódulos e FR reagente sustenta artrite reumatoide estabelecida. Esperam-se osteopenia periarticular, redução uniforme do espaço articular e erosões marginais; deformidades podem acompanhar lesão avançada. A descrição temporal “há pelo menos 5 minutos” é internamente incoerente e foi preservada tal como apresentada. [1,2]

QUESTÃO 02

Resposta: Quadro compatível com fibromialgia; amitriptilina é opção, não obrigação

Dor difusa, sintomas do sono, fadiga e ausência de artrite objetiva sugerem fibromialgia. A avaliação continua clínica; o número de tender points não é requisito isolado nos critérios mais recentes. Exercício gradual, educação e estratégias não farmacológicas são centrais. Amitriptilina em baixa dose pode ser considerada conforme sono, dor, comorbidades e eventos adversos, não sendo necessária para todos. [5]

QUESTÃO 03

Resposta: Espondiloartrite axial (possível espondilite anquilosante); imagem das sacroilíacas

Dor lombar inflamatória de início jovem, melhora com atividade, rigidez e manobra sugestiva de comprometimento sacroilíaco sustentam a hipótese. Radiografia da pelve/sacroilíacas é avaliação inicial possível; a ressonância das sacroilíacas pode detectar sacroileíte precoce ou esclarecer radiografias normais. A imagem não substitui a avaliação clínica. [6]

QUESTÃO 04

Resposta: Gota crônica tofácea; terapia redutora de urato, geralmente alopurinol

Ataques recorrentes em pés, nódulos compatíveis com tofos e erosões “em saca-bocado” são típicos. O alopurinol costuma ser a primeira escolha, começando em dose baixa, com titulação para uricemia-alvo <6 mg/dL e profilaxia anti-inflamatória no início. Confirmar cristais quando viável; avaliar função renal, interações e fatores de risco antes de prescrever. [3]

QUESTÃO 05

Resposta: Manobra de Phalen

A flexão sustentada dos punhos pode reproduzir parestesias na distribuição do nervo mediano. É teste provocativo de síndrome do túnel do carpo, mas não confirma isoladamente o diagnóstico; sintomas, exame e, em situações específicas, eletroneuromiografia ou ultrassom complementam.

QUESTÃO 06

Resposta: Critérios SLICC 2012: mielite, alopecia não cicatricial e redução de complemento

As três manifestações foram contempladas pela revisão SLICC de 2012: mielite dentro dos critérios neurológicos; alopecia não cicatricial entre os clínicos; e C3/C4 baixos entre os imunológicos. Isso não significa diagnóstico com apenas esses itens. Os critérios EULAR/ACR 2019 têm estrutura e pontuação diferentes. [7,8]

QUESTÃO 07

Resposta: SEM ALTERNATIVA INEQUIVOCAMENTE CORRETA

O enunciado exige resposta única, mas generaliza prevenção, rastreamento e tratamento. A teriparatida pode ser escolhida para risco muito alto de fratura, não para toda osteoporose com fratura. A oferta de cálcio e vitamina D deve ser adequada, por dieta e/ou suplementação conforme necessidade, e exercícios devem ser individualizados. [9]

a) Incorreta como regra geral: exercício com carga/fortalecimento é útil e deve ser adaptado ao risco de fraturas vertebrais e quedas.

b) Não universal: teriparatida pode ser preferida em risco muito alto, especialmente fraturas vertebrais múltiplas, mas não é escolha automática após qualquer fratura.

c) Incorreta: rastreamento universal é recomendado a partir dos 65 anos em mulheres, antes apenas conforme fatores de risco/indicação.

d) Afirmação absoluta inadequada: cálcio e vitamina D suficientes são parte do cuidado; suplementos dependem da ingestão e dos níveis, não são obrigatórios a todos.

QUESTÃO 08

Resposta: A, B e C — todas as alternativas são verdadeiras

O fator reumatoide não é exclusivo de artrite reumatoide e pode aparecer em síndrome de Sjögren, hepatite C e em parcela de pessoas idosas sem doença reumatológica definida. A pergunta não especifica “apenas uma”, mas seria inadequado indicar resposta única.

a) Verdadeira. Síndrome de Sjögren pode cursar com FR positivo.

b) Verdadeira. Hepatite C e crioglobulinemia associada podem cursar com FR positivo.

c) Verdadeira. Há positividade em parcela de idosos, sem AR; valor clínico depende de sintomas e título.

QUESTÃO 09

Resposta: Estreitamento do espaço articular e osteófitos marginais

A osteoartrite pode cursar com perda de espaço articular, osteófitos, esclerose subcondral e cistos subcondrais. A radiografia pode apoiar o diagnóstico, mas sua intensidade nem sempre se correlaciona com a dor.

QUESTÃO 10

Resposta: Celecoxibe: anti-inflamatório com seletividade pela COX-2

As ciclooxigenases convertem ácido araquidônico em precursores de prostaglandinas e tromboxanos. Celecoxibe é inibidor seletivo de COX-2 (não completamente isento de efeito COX-1) e mantém riscos cardiovasculares, renais e gastrintestinais, ainda que tenha menor toxicidade ulcerogênica relativa que alguns AINEs não seletivos.

QUESTÃO 11

Resposta: Artrite reativa

Artrite assimétrica de membros inferiores após uretrite, com conjuntivite, é apresentação típica. Não é obrigatório existir a tríade completa. Avaliar infecção sexualmente transmissível ativa, investigar outras causas de artrite e excluir artrite séptica quando pertinente.

QUESTÃO 12

Resposta: Radiografia das mãos e ultrassonografia do ombro direito

Nódulos em IFP/IFD e dor mecânica sugerem osteoartrite de mãos; sintomas de ombro podem decorrer de afecção do manguito rotador ou bursite. RX evidencia alterações degenerativas; ultrassom auxilia a avaliar tendões e bursa. Exames são úteis quando indicados, não necessariamente “essenciais” em toda apresentação típica.

QUESTÃO 13

Resposta: Suspeita de gota aguda: anti-inflamatório apropriado e exclusão de infecção

A monoartrite aguda em usuário de hidroclorotiazida, com álcool e episódio similar, sugere gota. A escolha inicial é AINE, colchicina ou glicocorticoide conforme contexto; artrocentese com cultura é importante se houver possibilidade de artrite séptica. Alopurinol destina-se ao controle de longo prazo e só deve ser introduzido quando indicado, com profilaxia; pode ser iniciado durante a crise tratada. [3,10]

QUESTÃO 14

Resposta: Investigação de LES: FAN, anti-dsDNA/anti-Sm, complemento e avaliação de órgãos

Artrite inflamatória, pleurite, citopenia prévia e anemia levantam hipótese de LES. FAN é exame inicial adequado; hemograma, exame urinário/proteinúria, função renal, C3/C4 e anticorpos específicos ajudam na avaliação. Radiografia de tórax é pertinente pela tosse e dor ventilatório-dependente, mas não confirma LES por si. [7,8]

QUESTÃO 15

Resposta: Anti-CCP; ressonância de mãos apenas se dúvida persistente

Quadro de sinovite inflamatória sugere artrite reumatoide mesmo com FR negativo (possível AR soronegativa). Anti-CCP aumenta a especificidade; ultrassom com Doppler ou RM podem detectar sinovite subclínica. RM não é exame de rotina obrigatório nem deve atrasar a decisão terapêutica. [2]

QUESTÃO 16

Resposta: Hanseníase, entre os diagnósticos diferenciais

Em áreas endêmicas, hanseníase pode causar artrite, neuropatia e manifestações que simulam reumatismos; examinar pele, nervos periféricos e sensibilidade. Considerar ainda hepatites virais, espondiloartrites e doenças sistêmicas segundo o contexto.

QUESTÃO 17

Resposta: Cristais de urato: birrefringência NEGATIVA, em agulha

Cristais de urato monossódico são tipicamente alongados e exibem birrefringência fortemente negativa à microscopia com luz polarizada compensada. Cristais de pirofosfato de cálcio têm, em geral, birrefringência positiva fraca. A resposta previamente inserida no arquivo estava invertida e não foi utilizada.

QUESTÃO 18

Resposta: Baixo IMC e tabagismo

Ambos são fatores de risco reconhecidos para baixa massa óssea e fratura. Acrescentam-se idade, fratura prévia, glicocorticoides, consumo excessivo de álcool, história familiar e causas secundárias. [9]

QUESTÃO 19

Resposta: Teste de Phalen

Flexão sustentada dos punhos pode provocar sintomas do nervo mediano. O teste é sugestivo, mas depende de correlação com história/exame e não dispensa outras avaliações quando há déficit motor ou diagnóstico duvidoso.

QUESTÃO 20

Resposta: Dor posterior no FABER pode sugerir disfunção sacroilíaca, mas não diagnostica isoladamente

FABER (flexão, abdução, rotação externa) tensiona quadril e região sacroilíaca. Dor posterior pode sugerir origem sacroilíaca; dor inguinal aponta mais para o quadril. O resultado não é sinônimo específico de sacroileíte inflamatória.

QUESTÃO 21

Resposta: Artrocentese urgente com estudo do líquido sinovial

Diante de monoartrite aguda com derrame importante, é necessário afastar artrite séptica: contagem celular, diferencial, Gram, cultura e pesquisa de cristais. Atividade esportiva e comportamento sexual não identificam sozinhos o agente. Cristais, se presentes, não afastam infecção concomitante. [10]

QUESTÃO 22

Resposta: A afirmação apresentada é INCORRETA; oligoartrite assimétrica não é a forma menos comum

O fenótipo oligoarticular assimétrico é clássico, frequentemente observado no início da artrite psoriásica. A distribuição varia com duração e população; artrite mutilante é incomum. Como o documento fornece uma frase e não as alternativas originais, não se pode comparar eventuais demais opções. [11]

QUESTÃO 23

Resposta: A esclerose sistêmica predomina em mulheres, com início habitualmente na vida adulta

Predomínio feminino da ordem de 3–5:1 é descrito; faixas de idade dependem da população estudada, com muitos casos a partir de 30–50 anos. A formulação “principalmente quinta e sexta décadas” é excessivamente categórica como regra universal. Sem alternativas originais, não há julgamento comparativo.

QUESTÃO 24

Resposta: Sensação subjetiva de edema pode ocorrer na fibromialgia

A paciente pode descrever mãos ou outras áreas “inchadas” sem edema ou sinovite observável. Isso não substitui a investigação de sinais objetivos de inflamação e de outras causas de edema. [5]

QUESTÃO 25

Resposta: Parestesias noturnas aliviadas ao sacudir as mãos são típicas

O comprometimento do nervo mediano causa sintomas em polegar, indicador, médio e metade radial do anular. Despertar noturno e alívio com movimento da mão sustentam síndrome do túnel do carpo.

QUESTÃO 26

Resposta: Erosões precoces, muitas articulações inflamadas e FR em alto título

Erosões, alta carga inflamatória e positividade significativa de FR/anti-CCP associam-se a maior risco de dano estrutural e persistência da AR. Não existe um limite universal de “20 articulações” indispensável ao mau prognóstico. [2]

QUESTÃO 27

Resposta: Mesma resposta da questão 26 (questão duplicada no material)

A questão 27 está integralmente repetida no PDF de origem; foi mantida para garantir as 46 questões e a numeração. Erosões precoces, poliartrite extensa e FR de alto título sinalizam maior risco de progressão, no contexto clínico. [2]

QUESTÃO 28

Resposta: Anti-Sm

Anti-Sm tem elevada especificidade para LES, embora baixa sensibilidade. O FAN é mais sensível e menos específico, de modo que sua positividade isolada não confirma a doença. Anti-dsDNA também é bastante específico conforme o método. [8]

QUESTÃO 29

Resposta: Espondiloartrite axial / espondilite anquilosante, com possível uveíte anterior

Dor lombar inflamatória, entesite calcânea e olho doloroso com fotofobia e perda visual sugerem espondiloartrite com uveíte anterior aguda. A queixa ocular exige avaliação oftalmológica urgente; RX/RM sacroilíacas podem complementar a investigação. [6]

QUESTÃO 30

Resposta: Osteoartrite

Nódulos em IFP/IFD, crepitação, dor relacionada à carga e ausência de sinovite marcante favorecem osteoartrite de mãos, joelhos e coluna.

QUESTÃO 31

Resposta: Tratar crise de gota com AINE OU colchicina, conforme riscos clínicos

Podagra aguda e crises anteriores sugerem gota. AINE, colchicina em baixa dose ou glicocorticoide são opções de primeira linha; a combinação AINE+colchicina não é obrigatória. Avaliar necessidade de reposicionar a hidroclorotiazida, mas não suspender AAS cardioprotetor sem avaliar sua indicação. Excluir artrite séptica quando pertinente. [3,10]

QUESTÃO 32

Resposta: A — lúpus eritematoso sistêmico

Artrite, anemia, leucopenia, trombocitopenia, hipoalbuminemia, edema e derrame pleural sugerem LES com possível serosite e acometimento renal; a proteinúria deve ser medida. FAN alto apoia, mas não confirma sozinho. Anti-dsDNA/anti-Sm, C3/C4 e avaliação renal são prioridades. ASO alto isolado não demonstra febre reumática. [7,8]

a) Correta: LES explica melhor a combinação de artrite, citopenias, derrame pleural, FAN alto e suspeita renal.

b) Incorreta: AR isolada não explica tão bem citopenias importantes, serosite e provável envolvimento renal nesta mulher jovem.

c) Incorreta: Sjögren pode ter manifestações sistêmicas, mas faltam queixas glandulares e o conjunto favorece LES.

d) Incorreta: ausência de psoríase/dactilite/entesite e presença de citopenias e serosite tornam artrite psoriásica menos provável.

QUESTÃO 33

Resposta: Artrite reumatoide

Poliartrite simétrica persistente com rigidez prolongada, nódulo extensor, FR alto e erosões é fortemente sugestiva de AR. A classificação é clínica, sorológica e inflamatória; anti-CCP pode auxiliar. [2]

QUESTÃO 34

Resposta: Sem alternativa única garantida: A é razoável; C depende do contexto; B não é rotina

Em poliartrite crônica, o FAN pode auxiliar quando se suspeitam conectivopatias; anti-HCV é pertinente com exposições ou suspeita de artrite relacionada ao HCV. Pesquisa de BAAR pode ser indicada diante de suspeita específica de hanseníase ou tuberculose osteoarticular, mas não é rastreamento universal da poliartrite. Ausência de outras opções e dados impede gabarito único absoluto.

a) Possível, se o diferencial incluir LES ou outra conectivopatia; FAN não diagnostica AR e não precisa ser feito indiscriminadamente.

b) Não usual no rastreamento da poliartrite; a pesquisa de BAAR é dirigida à suspeita de hanseníase ou tuberculose, conforme local de coleta e quadro clínico.

c) Possível e por vezes importante diante de fatores de risco ou artrite/vasculite/crioglobulinemia por hepatite C; a necessidade não é estabelecida pelo enunciado.

QUESTÃO 35

Resposta: A, C e D — alternativas possíveis; B não é associação típica

FR pode estar presente em síndrome de Sjögren, algumas infecções crônicas como hanseníase e em pessoas idosas sem AR. Osteonecrose, isoladamente, não costuma gerar positividade de FR. O item é multirresposta se exige identificar condições em que FR pode ser detectado.

a) Verdadeira: síndrome de Sjögren frequentemente cursa com FR positivo.

b) Falsa como associação usual: osteonecrose não é causa reconhecida de FR positivo por si só.

c) Verdadeira como possibilidade: hanseníase é infecção crônica que pode produzir autoanticorpos, inclusive FR.

d) Verdadeira como possibilidade: o FR pode ser detectado em idosos sem AR.

QUESTÃO 36

Resposta: Síndrome do intestino irritável

Fibromialgia pode coexistir com síndrome do intestino irritável, fadiga, alterações de sono, cefaleias e outras síndromes funcionais. O diagnóstico não exige tender points, apesar da descrição histórica do material. [5]

QUESTÃO 37

Resposta: Desencorajar consumo excessivo de álcool

Uso crônico intenso de álcool prejudica remodelação óssea, aumenta quedas e reduz saúde óssea. Cessar tabagismo, manter exercício seguro e garantir ingestão adequada de cálcio/vitamina D integram a abordagem. [9]

QUESTÃO 38

Resposta: Crepitação pode acompanhar degeneração articular, mas é inespecífica

O ruído/atrito na mobilização pode refletir alterações de cartilagem, superfícies articulares e tendões; em osteoartrite é achado frequente. Isoladamente não demonstra destruição cartilaginosa nem estabelece diagnóstico.

QUESTÃO 39

Resposta: Osteoartrite de joelhos

Dor mecânica, crepitação, excesso ponderal, osteófitos, esclerose subcondral e diminuição do espaço articular constituem quadro característico. Intervenções incluem exercício e fortalecimento, controle do peso e analgesia conforme risco.

QUESTÃO 40

Resposta: FR, anti-CCP e radiografias de mãos/pés; diagnóstico essencialmente clínico

O padrão clínico com sinovite persistente, rigidez matinal e nódulos sugere AR; FR e anti-CCP apoiam, e radiografias avaliam erosões. A presença de FR não é suficiente nem indispensável e RX normal não afasta artrite precoce. [2]

QUESTÃO 41

Resposta: Hidroxicloroquina, se LES confirmado e sem contraindicação

Artrite, alopecia, úlceras orais e fotossensibilidade sugerem LES. A hidroxicloroquina é recomendada de base na maioria dos pacientes com diagnóstico, com acompanhamento oftalmológico; é necessário avaliar acometimento de órgãos e testes específicos. FAN alto isolado não estabelece confirmação. [8,12]

QUESTÃO 42

Resposta: Suspeita de gota aguda; AINE, colchicina ou glicocorticoide

Monoartrite abrupta e crises anteriores de podagra são sugestivas de gota. Tratar inflamação precocemente, considerar artrocentese sobretudo no primeiro quadro ou se houver suspeita infecciosa. AINE+colchicina não é combinação obrigatória. [3,10]

QUESTÃO 43

Resposta: Supraespinhal é hipótese plausível, não diagnóstico exclusivo

Dor à elevação e sinal de Neer podem ocorrer na síndrome dolorosa subacromial, incluindo tendinopatia do supraespinhal. Neer não identifica isoladamente qual tendão está lesionado; complementam testes de Jobe, força e imagem quando indicada.

QUESTÃO 44

Resposta: Em geral, bisfosfonato mais aporte adequado de cálcio e vitamina D, conforme risco

Aos 82 anos, após confirmar osteoporose, geralmente há indicação de tratamento antiosteoporótico farmacológico, com escolha individual (por exemplo bisfosfonato, conforme função renal e contraindicações). Garantir cálcio dietético e vitamina D suficientes; suplementar quando necessário. Avaliar quedas e fraturas prévias. [9]

QUESTÃO 45

Resposta: Fibromialgia: predomínio feminino, dor generalizada e alterações do sono

A afirmação é compatível com apresentação habitual; hipotireoidismo entra no diagnóstico diferencial de dor e fadiga difusas. Contudo, no arquivo não existem alternativas reais para marcar; a frase após os dois-pontos era uma resposta pré-preenchida, removida da prova limpa. [5]

QUESTÃO 46

Resposta: Sindesmófitos marginais e quadratura vertebral

Na espondilite anquilosante, podem aparecer retificação do contorno vertebral (quadratura), sindesmófitos finos verticais e pontes ósseas, culminando em “coluna em bambu”. Alterações iniciais podem estar ausentes no RX; ressonância tem papel na doença precoce. [6]

Observações sobre a integridade das questões

• Questões 26 e 27: são duplicadas no arquivo original; ambas foram mantidas para não excluir qualquer questão.

• Questões 7, 8, 34 e 35: a ausência de resposta única válida foi expressamente indicada. Questão 17: a resposta preexistente estava incorreta quanto à birrefringência.

• Questões 22, 23 e 45: foram fornecidas sem alternativas comparáveis no PDF; após a retirada das respostas incorporadas, foram mantidos os comandos originais, e o comentário aponta essa limitação.

• As afirmações da questão 1 sobre tempo de sintomas e os demais erros tipográficos foram mantidos. Dados clínicos não apresentados não foram presumidos.

• O presente gabarito é interpretativo e bibliograficamente fundamentado; não equivale ao gabarito oficial nem substitui avaliação médica.

Referências selecionadas e links de consulta

[1] RA: aspectos radiográficos e avaliação. https://ard.bmj.com/content/72/6/804

[2] EULAR 2016: abordagem da artrite inicial. https://ard.bmj.com/content/76/6/948

[3] ACR 2020: tratamento da gota. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10563586/

[4] ACR 2021: terapêutica da artrite reumatoide. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9273041/

[5] EULAR: recomendações para fibromialgia (2016/2017). https://ard.bmj.com/content/76/2/318.long

[6] EULAR: recomendações de imagem em espondiloartrites. https://ard.bmj.com/content/74/7/1327

[7] Petri e cols.: critérios SLICC 2012 para LES. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3409311/

[8] EULAR/ACR: critérios classificatórios LES 2019. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6827566/

[9] Bone Health & Osteoporosis Foundation: guia clínico 2022. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9546973/

[10] SANJO 2023: diretriz para artrite séptica de articulações nativas. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9901514/

[11] Artrite psoriásica: variação de apresentação e subtipos. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547710/

[12] EULAR 2023: recomendações de manejo do LES. https://ard.bmj.com/content/83/1/15